

健康体检报告

MEDICAL EXAMINATION REPORT

杨少鹏

项目号: T052090001

性别: 男

单位: 博世创新软件开发(无锡)有限公司

联系电话: 182****3079

项目简称: 博世创新软件

员工号: 85042056

类别: 员工

卡号: 0021002178856701

部门: RBCN/ESC-PjM-PS

递送地址:

报告递送方式: 电子版报告

体检号: 2222010100229



无锡爱康国宾门诊部有限公司(爱康国宾无锡新吴茂业分院)

检查日期: 2020.10.10

31 / 6227



爱康国宾是中国最大的健康管理集团之一,每年为数百万客户提供健康体检、疾病检测、齿科服务和私人医生等服务。依托旗下健康医疗服务中心、IT技术平台和强大的客户服务体系,爱康国宾为个人及团体提供从体检、检测、医疗、齿科、家庭医生、慢病管理、健康保险等全方位个性化服务,帮助其全面摆脱亚健康、预防慢性病、解决就医难,为根本提高现代中国人的整体健康水平和生命质量作贡献。同时,爱康国宾为保险公司以及银行提供第三方的健康管理服务以及客户关系管理的解决方案

爱康的体检中心城市(已在官网正式上线展示的城市)包括:北京、上海、广州、深圳、南京、成都、凯里、杭州、苏州、重庆、天津、长春、沈阳、绵阳、烟台、济南、潍坊、威海、青岛、常州、镇江、江阴、无锡、芜湖、宁波、福州、佛山、长沙、武汉、西安、银川、贵阳、毕节。

爱康国宾健康体检管理集团有限公司 版权所有

www.ikang.com

尊敬的 杨少鹏 先生: 您好!

无锡爱康国宾门诊部有限公司(爱康国宾无锡新吴茂业分院)感谢您的光临和对我们的信任和支持。现将您2020年10月10日的体检报告呈上。

报告阅读说明

您本次体检报告由健康信息、本次体检主要阳性结果和异常情况、专家指导建议及本次体检结果等部分组成。

健康体检数据只是针对本次体检覆盖的相关器官的相关项目或指标的检查结果,并非能覆盖人体全部器官及全部指标。

您的体检报告结论是基于您提供的健康信息及本次临床检查结果,隐瞒和错误的信息都可能会误导医生作出错误的判断。如果您提供的健康信息不完整,可能会导致相关检查结论有偏差。

因为检查方法的不同,针对同一器官或者系统的检查结果可能会有所差异。

由于体检选项、检查方法及医学本身的局限性,本次体检未见异常并不代表没有疾病,如您有不适症状,请及时到医院就诊。

阳性结果和异常情况

- 【1】 体重指数增高;轻度脂肪肝;总胆固醇增高
- 【2】 本次体检血压增高;未提供高血压病史
- 【3】 左侧甲状腺结节

专家建议与指导

【1】 体重指数增高;轻度脂肪肝;总胆固醇增高:
体重指数(体重(kg)÷身高(m)的平方)≥24为超重,≥28为肥胖。您的体重已属超重范围,同时合并轻度脂肪肝和血脂偏高。超重和血脂高是高血压、冠心病的危险因素,也是糖尿病、高脂血症和高血液粘稠度等的病因;脂肪肝多由营养过剩、饮酒、药物损伤导致,加重可导致肝纤维化。您需要调整饮食结构,用低脂、低热、少糖膳食,坚持有氧运动,减轻体重,限酒,慎用伤肝药物,定期复查,听取专科医生的意见。

【2】 本次体检血压增高;未提供高血压病史:
1、收缩压≥140mmHg和/或舒张压≥90mmHg为血压增高标准。
2、请近期监测血压,若三次以上非同日测得收缩压≥140mmHg和/或舒张压≥90mmHg,有高血压病之可能,建议去医院专科就诊,明确有否高血压病。
3、高血压与遗传、肥胖、饮食习惯、睡眠、精神压力等因素有关。建议您改善生活方式,戒烟限酒,低脂、低盐、合理膳食,坚持有氧运动,控制体重,减轻精神压力、保持心理平衡等。

【3】 左侧甲状腺结节:
是临床常见的病征,成人中约4%可发生甲状腺结节,恶性病变虽不常见,但术前难以鉴别。若甲状腺结节为孤立结节、突然迅速、无痛地增大或有甲状腺肿瘤家族史者,建议您及时去医院专科做进一步检查,以便明确诊断。

进一步检查项目建议

(基于发现的异常结果,建议您做以下检查,从而进一步排除或确定您的健康隐患)

序号	发现的异常结果	建议进一步检查的项目 (最终以临床医师意见为准)
1	血压增高	必要时,应进行24小时动态血压监测或家庭血压监测。

主要参考:国家卫生和计划生育委员会、中华医学会、美国癌症学会、美国心脏学会、美国妇产科医师学会等学术机构发布的相关标准

异常结果复查建议

序号	发现的异常结果	复查建议 (最终以临床医师意见为准)
1	体重指数增高	3-12个月复查。
2	轻度脂肪肝	每年复查一次超声、肝功能。

健康体检结果

• 一般项目检查				检查者：彭千伶
检查项目	测量结果	单位	异常描述	正常参考值
身高	175.0	cm		
体重	73.5	Kg		
体重指数	24.0		↑	18.5 -- 23.99
收缩压	143	mmHg	↑	90 -- 139
舒张压	84	mmHg		60 -- 89
初步意见	体重指数增高 血压增高			

• 内科			检查者：李继强
检查项目	检查所见	单位	
病史	无		
家族史	无特殊		
心率（次/分）	72	次/分	
心律	齐		
心音	正常		
肺部听诊	双侧呼吸音未闻及异常		
肝脏触诊	肝脏肋下未触及		
脾脏触诊	脾脏肋下未触及		
肾脏叩诊	双肾区无叩痛		
内科其它	无		
初步意见	未见明显异常		

• 心电图室			检查者：李继强
检查项目	检查所见	单位	
心电图	窦性心律 正常心电图		
初步意见	未见明显异常		

• 外科		检查者： 赵进南
检查项目	检查所见	单位
皮肤	未见明显异常	
浅表淋巴结	颈部、锁骨上、腋窝及腹股沟未见明显异常	
甲状腺(外科)	未见明显异常	
乳房	未见明显异常	
脊柱	未见明显异常	
四肢关节	未见明显异常	
外生殖器	未见明显异常	
肛门、直肠指诊	未见明显异常	
前列腺(外科)	未见明显异常	
外科其它	无	
初步意见	未见明显异常	

• 眼科		检查者： 张倩
检查项目	检查所见	单位
外眼	未见明显异常	
眼科其它	无	
眼底镜检查	未见明显异常	
左眼非接触性眼压 (mmHg)	20	mmHg
右眼非接触性眼压 (mmHg)	19	mmHg
初步意见	未见明显异常	

耳鼻咽喉科

此项目你已同意放弃检查，本次报告将不包含此检查结果。

• 血常规

审核者： 谢明

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位
白细胞计数	WBC	5.3		3.5 -- 9.5	10 ⁹ /L
红细胞计数	RBC	4.98		4.3 -- 5.8	10 ¹² /L
血红蛋白	Hb	156.00		130 -- 175	g/L
红细胞比容	HCT	0.460		0.4 -- 0.5	L/L
平均红细胞体积	MCV	92.40		82 -- 100	fL
平均红细胞血红蛋白含量	MCH	31.30		27.0 -- 34.0	pg

平均红细胞血红蛋白浓度	MCHC	339.00		316 -- 354	g/L
红细胞分布宽度-变异系数	RDW-CV	11.40		10 -- 16.5	%
血小板计数	PLT	221.00		125 -- 350	10 ⁹ /L
平均血小板体积	MPV	5.70		5 -- 12.4	fL
血小板分布宽度	PDW	15.90		9 -- 18.0	FL
淋巴细胞百分比	LYMPH%	29.30		20 -- 50	%
中性粒细胞百分比	NEUT%	64.40		40 -- 75	%
淋巴细胞绝对值	LYMPH	1.55		1.1 -- 3.2	10 ⁹ /L
中性粒细胞绝对值	NEUT	3.42		1.8 -- 6.3	10 ⁹ /L
红细胞分布宽度-标准差	RDW-SD	42.13		37.8 -- 51.0	fL
血小板压积	PCT	0.130		0.1 -- 1.00	%
单核细胞百分比	MONO%	5.60		3 -- 10	%
单核细胞绝对值	MONO	0.29		0.1 -- 0.6	10 ⁹ /L
嗜酸性细胞百分比	EOS%	0.4		0.4 -- 8.0	%
嗜酸性细胞绝对值	EOS	0.020		0.02 -- 0.52	10 ⁹ /L
嗜碱性细胞百分比	BASO%	0.47		0.0 -- 1.0	%
嗜碱性细胞绝对值	BASO	0.02		0.0 -- 0.06	10 ⁹ /L
小结	未见明显异常				

此检验结果仅对本次标本负责，仅供临床参考

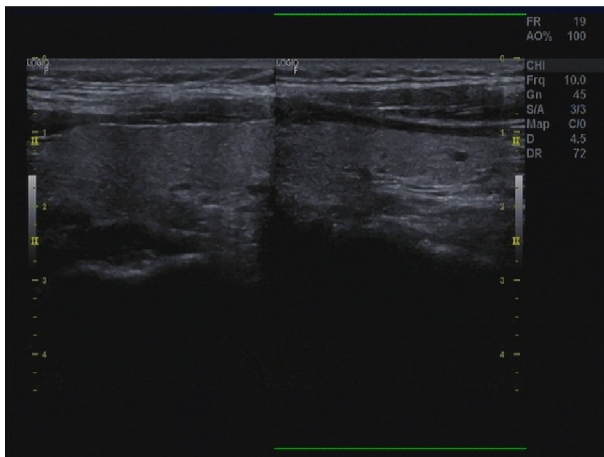
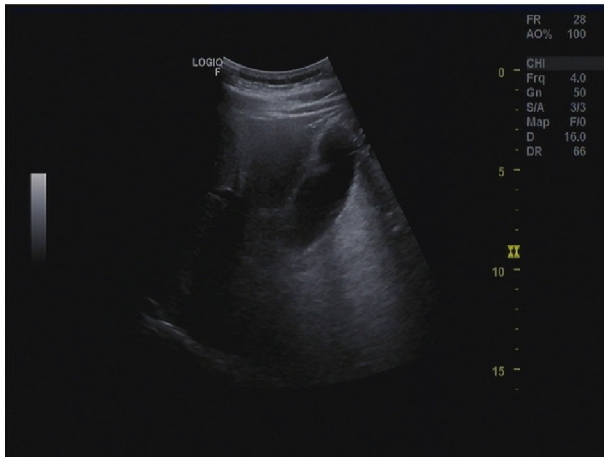
• 尿常规					审核者： 谢明
检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位
尿比重	SG	1.020		1.010 -- 1.025	
尿酸碱度	PH	6.5		4.5 -- 8.0	
尿白细胞	LEU	阴性		阴性	Cell/uL
尿亚硝酸盐	NIT	阴性		阴性	
尿蛋白质	PRO	阴性		阴性	g/L
尿糖	GLU	阴性		阴性	mmol/L
尿酮体	KET	阴性		阴性	mmol/L
尿胆原	URO	阴性		阴性	umol/L
尿胆红素	BIL	阴性		阴性	umol/L
尿隐血	BLD	阴性		阴性	Cell/uL
小结	未见明显异常				

此检验结果仅对本次标本负责，仅供临床参考

• 实验室检查					审核者： 谢明
检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位
丙氨酸氨基转移酶	ALT	43.7		7 -- 50	U/L
碱性磷酸酶	ALP	53.7		35 -- 135	U/L
肌酐	Cr	94.50		44 -- 106	umol/L
尿酸	UA	407.70		155 -- 428	umol/L
空腹血糖	FBG	5.86		3.90 -- 6.10	mmol/L
总胆固醇	TC	5.25	↑	0 -- 5.2	mmol/L
甘油三酯	TG	2.10		0 -- 2.26	mmol/L
高密度脂蛋白胆固醇	HDL-C	1.47		0.91 -- 1.68	mmol/L
低密度脂蛋白胆固醇	LDL-C	3.12		0 -- 4.14	mmol/L
甲胎蛋白定量	AFP	2.94		0 -- 20	ng/ml
癌胚抗原定量	CEA	0.41		0 -- 5	ng/ml
小结	总胆固醇增高				

此检验结果仅对本次标本负责，仅供临床参考

• 超声检查室		检查者： 李永春
检查项目	检查所见	单位
肝	肝脏形态大小正常，内部回声光点细小、密集，浅部组织回声略增强，深部组织回声略有衰减。管道结构显示尚清晰。CDFI：血流显示正常	
胆	未见明显异常	
胰	未见明显异常	
脾	未见明显异常	
双肾	未见明显异常	
前列腺	未见明显异常	
甲状腺	双侧甲状腺形态大小正常，左侧叶见边界尚清晰的结节，大小约2×1mm。CDFI：血流未见明显异常	
初步意见	轻度脂肪肝 左侧甲状腺结节	



温馨提示: 本报告所含图片, 均是为了配合文字表述所配发, 不能用于二次诊断或其他任何医学判断目的使用。

• 放射科		检查者: 孙明
检查项目	检查所见	单位
胸部	双肺纹理较清晰, 肺野未见明显实变影。双肺门结构尚清晰。心影大小尚属正常范围之内。双侧膈面光整, 肋膈角锐利。	
初步意见	心肺膈未见明显异常	

主检医师: 赵进南

医学名词科普知识

医学名词科普知识内容, 仅是帮助您解读理解体检报告使用, 所有名词的解释内容, 均出自国家权威性专业典籍, 部分内容略有增减, 仅供您阅读参考。

● 什么是总胆固醇增高?

总胆固醇是指血液中含有脂蛋白所含胆固醇之总和, 包括游离胆固醇和胆固醇酯。血清总胆固醇水平与年龄、家族、性别、饮食、精神、遗传等多种因素有关。总胆固醇增高的原因包括高脂蛋白血症、糖尿病、甲状腺功能减退症、胆汁淤积性黄疸、类脂性肾病、肾病综合征等疾病, 长期吸烟、饮酒、精神紧张等也会引起总胆固醇增高。总胆固醇轻度增高时临床症状不显著或无临床症状, 明显升高时有不同程度的头晕、肢体麻木等症状。胆固醇是动脉粥样硬化的重要危险因素之一。总胆固醇增高考虑血脂异常, 建议及时复查, 改变饮食习惯, 加强体育锻炼, 防止发生动脉粥样硬化等疾病; 对于已经伴有血脂升高、动脉硬化或者有冠心病、中风家族史者及时到内科就诊, 预防心脑血管疾病的发生; 养成定期体检的习惯, 全面检测血脂。

● 什么是体重指数?

目前常用的体重指数 (body mass index) 简称BMI, 又译为体质指数。在判断肥胖程度时, 使用这个指标的目的在于消除不同身高对体重指数的影响, 以便于人群或个体间比较。研究表明, 大多数个体的体重指数与身体脂肪的百分含量有明显的相关性, 能较好地反映机体的肥胖程度。但在具体应用时还应考虑到其局限性, 如对肌肉很发达的运动员或有水肿的病人, 体重指数值可能过高估计其肥胖程度。老年人的肌肉组织与其脂肪组织相比, 肌肉组织的减少较多, 计算的体重指数值可能过低估计其肥胖程度。相等BMI值的女性的体脂百分含量一般大于男性。同时测定体脂百分含量 (体脂%) 会有助于判断肥胖程度。

● 什么是脂肪肝?

指肝脏内脂肪含量增多, 过度充积于肝细胞内超过正常范围。脂肪充盈于肝细胞内可减弱其功能, 易受亲肝性毒物所损害, 甚至发展为肝硬化。脂肪肝为可逆性, 在合理治疗后可恢复正常。因此早期诊断有重要临床意义。大多数脂肪肝患者没有症状。有些患者可感觉疲劳、不适或右上腹不适。B超、CT有辅助诊断意义, 确诊必须依靠肝活检。脂肪肝形成原因包括饮食不当、长期大量饮酒、过度肥胖等。防治脂肪肝主要靠调整饮食习惯和结构。

● 什么是糖尿病?

糖尿病 (DM) 是一组以高血糖为特征的代谢综合征, 由于体内胰岛素分泌缺陷或其生物学作用障碍而引起的糖、蛋白质、脂肪和水电解质代谢紊乱, 常并发全身微血管、大血管病变, 并可导致心、脑、肾、神经、眼睛及足等器官的慢性功能损害。糖尿病分为1型糖尿病、2型糖尿病、妊娠糖尿病、特殊类型糖尿病, 其中90%以上糖尿病为2型糖尿病。

● 什么是纤维化?

内脏器官等病损后由纤维组织取代或间质纤维组织增生的过程, 叫纤维化。常是变性炎症、缺血、坏死、创伤等引起的后果。如创伤后伤口内产生肉芽组织并逐渐转为纤维化, 最后形成瘢痕。发生在内脏器官 (如心、肺、肝等) 的弥漫性纤维化, 可引起脏器变形、变硬, 故有硬化之称, 如肝硬化。纤维化的后果按其发生部位及范围而异, 如皮肤局限性纤维化的影响较小; 而心瓣膜的纤维化或瘢痕形成, 常引起瓣膜变形, 形成狭窄和闭锁不全, 导致心力衰竭。

● 什么是血压?

人体血液不停流动的原动力是我们的心脏, 心脏收缩时血液送入主动脉, 心脏舒张时血液从体循环回流至心脏。心脏的收缩和舒张交替进行, 推动血液在心脏和血管组成的密闭循环系统内持续流动。血液在血管内流动时对血管壁造成的压力, 叫做血压。当心脏收缩时, 大量的血液射入动脉, 此时血液对动脉的压力最高, 称为收缩压 (俗称高压)。健康的动脉壁富有弹性, 当心脏收缩时射入动脉的血液有一部分会暂时蓄积在弹性膨胀的主动脉内, 而不是一次性地送入全身, 这样就保证了收缩压不会升得太高。心脏舒张时, 受到高压而膨胀的大动脉弹性回缩, 使血液仍能持续向前流动, 但压力下降, 此时的血压称为舒张压 (俗称低压)。

● 什么是血脂?

血脂是血浆中的胆固醇、甘油三酯 (TG) 和类脂如磷脂等的总称。血脂是一个大家庭, 血脂家庭中有四个“兄弟”。“大哥”总胆固醇, “二哥”甘油三酯, “三哥”低密度脂蛋白胆固醇, 这三个人本身都是好人, 都是有用的人, 但是不能太多了。一多他们就不务正业, 游手好闲, 到处堵塞马路, 妨碍交通, 变成了“坏人”。因此, 血脂并不是“好”与“坏”的问题, 而是“多”与“少”的问题。血脂中还有一个“四弟”叫高密度脂蛋白胆固醇, 他也是好人, 其数量多了, 不但不游手好闲, 还能劝阻三位“大哥”不要堵塞交通, 并且主动疏导交通, 因此“四弟”是越多越好。

● 什么是甲状腺结节?

甲状腺结节是指甲状腺内散在的并能和周围甲状腺组织清楚分界的局限性肿块，其病因分为炎症、肿瘤、转移等。甲状腺结节多为良性，恶性结节仅占5%左右。多数良性甲状腺结节无明显临床症状，当肿大结节压迫周围组织时，出现声音嘶哑、憋气、吞咽困难等症状。甲状腺结节重点需鉴别良、恶性，及时到内分泌科或普外科就诊。甲状腺结节者，下列情况需引起足够的重视：①颈部放射线检查治疗史；②有甲状腺癌家族史；③年龄>70岁；④结节增长迅速且直径>2cm；⑤伴持续性声音嘶哑、发声困难、吞咽困难和呼吸困难；⑥结节质地硬、形状不规则、固定；⑦伴颈部淋巴结肿大。

深度咨询或风险评估产品建议

- 尊敬的用户您好，近年国内肠癌胃癌呈高发趋势，建议您和家人重点关注。
 - 您本次的体检报告显示，血脂相关检测项目出现异常结果。建议您调整血脂水平，延缓动脉硬化进程，降低动脉粥样硬化、周围血管病、冠心病的发病率。血脂异常主要包括总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇、甘油三酯升高和/或高密度脂蛋白胆固醇降低等。主要临床表现：①脂质在真皮内沉积所引起的黄色瘤；②脂质在血管内皮沉积所引起的动脉粥样硬化，产生冠心病和周围血管病等。后者造成相应器官或组织供血不足，导致冠心病，脑缺血性发作或脑梗死及周围血管病变。对已患冠心病者，高脂血症可促进冠心病事件（不稳定型心绞痛、急性心肌梗死、冠心病猝死）的发生。
- 向您推荐：使用爱康旗下的导医通APP，由专业医生免费为您提供检后血脂管理方案，为您指导用药，如他汀类、血脂康等药物，协助您尽快调节血脂到正常范围。

您可以通过下载爱康APP了解更多内容，或者关注爱康的相关产品宣传。

iKang 爱康



扫码下载爱康APP

想第一时间看到体检报告？
想对比您的历史体检报告？

爱康APP，检前检后全管理！

约体检

查报告

历史数据对比

专家解读

三甲医院挂号

iKangCare+，有人“管”的体检！